EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 83769
SERVICIO : MEL HOMBRES HSC
FECHA : 04-05-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EDUARDO ARIAS LUCO			**RUN**	: 7.818.633-K
F.Nac	: 18-12-1957	**Edad**	: 66 AÑOS, 4 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: KOIKO 8219 VOLLA LOS PUERTO I			**Comuna**	: PUDAHUEL
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-04-30	**Fecha Egreso**	: 04-05-2024	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnosticos:
1. Infección urinaria baja por Klebsiella pneumoniae BLEE + resuelta
2. Hiperpotasemia resuelta
3. Diabetes Mellitus tipo 2 insulino requirente
4. Hipertensión arterial

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. E87.5-HIPERPOTASEMIA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. U82.2-RESISTENCIA A BETALACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO(BLEE) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 66 años con antecedentes de DM2IR, HTA, artritis séptica y amputación de ortejo de pie izquierdo, ingresa al SU del HSC derivado desde consultorio el dia 29/04 con cuadro clínico de 4 dias de evolución caracterizado por dolor en flanco izquierdo irradiado a hipogastrio, acompañado de disuria, se realizan laboratorios que destacan UC (+) Klebsiella pneumoniae. BLEE+, sin elevación de parámetros inflamatorios, además destaca una hiperkalemia moderada con K 6.1, sin cambios electrocardiograficos resuelto en SU con medidas hipokalemiantes (K de ingreso a hospitalización: 5.1).Pielo TAC solicitado, informa microlitiasis izquierda sin signos de complicacion, engrosamiento parietal vesical, ateromatosis aortoiliaca. paciente ingresa a medicina en condiciones clinicas estables, hemodinamia autosostenida, metabolicamente compensado, inicialmente recibiendo ceftriaxona, que fue ajustado según antibiograma, a imipenem completando 5 dias, con buena respuesta, sin elevación de parámetros inflamatorios, afebril y asisntomatico, niega disuria, hematuria o tenesmo, sin nauseas, vomitos, diarrea. diuresis espontanea, el dia de ayer, dado evolución favorable, completando tratamiento antibiotico, sin clínica y paraclínicos que indican resolución de cuadro se decide derivacion a HODOM para cumplir restante y control en APS posterior

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen hiposódico, hipoglicemico
3. Hidratacion oral abundante
4. Ertapenem 1gr ev c24h por 2 dias
5. Paracetamol 500mg VO 2 comprimidos SOS dolor
6. Reanudar medicamentos crónicos
7. Control en APS: Ex de orina + UCT + PSA en 1 semana
8. Ante signos de alarma reconsultar al SU

EXÁMENES Y RESULTADOS

Pielo TAC: microlitiasis izquierda sin signos de complicacion, engrosamiento parietal vesical, ateromatosis aortoiliaca

Control en: 7 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO